

Lapse, *nie relapse*

Po poprawie przychodzą wzloty i upadki. Jeden epizod ≠ koniec. Wszystko, co osiągnęłeś/-aś, nie znika. Plan na sytuacje wysokiego ryzyka — i samowspółczucie po potknięciach.

CZAS: 15 min · aktualizacja co 3 mies. Faza końcowa terapii · po stabilizacji

ŹRÓDŁO: Marlatt & Gordon (1985); integracja BFRB (Mansueto, Woods); Bowen (MBRP)

JAK UŻYWAĆ

Zrozum różnicę między **lapse a relapse** (sekcja 1), zidentyfikuj **swoje sytuacje wysokiego ryzyka** (sekcja 2). W sekcji 3 — **plan działania** dla trzech sytuacji. Sekcja 4 — co zrobić po potknięciu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Marlatt & Gordon (1985) opracowali model profilaktyki nawrotów. Kluczowe rozróżnienie: **lapse** (potknięcie — pojedynczy epizod) *nie jest relapse* (powrót do pełnego wzorca). Marlatt opisał *abstinence violation effect*: pacjent po epizodzie myśli „wszystko stracone” → faktycznie nawraca. To **nie** dłubanie powoduje nawrót, lecz *interpretacja*. **Konsekwencja:** trening reakcji na potknięcie jest *równie ważny* jak trening unikania. Pacjenci z *planem na lapse* mają znacząco mniej relapse. Bowen (MBRP) dodała uważność: lapse jako *moment do obserwacji*, nie do osądu. Samowspółczucie po potknięciu = niższe ryzyko eskalacji. **Lapse to lekcja**, nie porażka.

01 ◎ Lapse vs relapse — kluczowa różnica

LAPSE · POTKNIĘCIE

Pojedynczy epizod dłubania po okresie poprawy. Krótki czas, ograniczone uszkodzenia. **Naturalna część** długoterminowej zmiany — występuje u 80%+ pacjentów.

RELAPSE · NAWRÓT

Powrót do pełnego wzorca, utrzymujący się dni/tygodnie. Często wynik *interpretacji* lapse, nie samego epizodu.

Marlatt: co decyduje, czy lapse stanie się relapse? *Reakcja* na lapse. Plan + samowspółczucie = powrót do techniki. Samokrytyka = eskalacja.

02 ✎ Moje sytuacje wysokiego ryzyka

Zidentyfikuj **3-5 sytuacji**, w których ryzyko dłubania jest największe. Typowe: stres egzaminacyjny, konflikt, samotność wieczorem, PMS, lustro w jasnym świetle, zmęczenie, alkohol.

SYTUACJA WYSOKIEGO RYZYKA #1

— konkretnie

SYTUACJA WYSOKIEGO RYZYKA #2

SYTUACJA WYSOKIEGO RYZYKA #3

CYKLICZNE (PMS, HORMONY, PORY ROKU)

— jeśli dotyczy

03 Plan działania dla 3 sytuacji

Dla każdej sytuacji z sekcji 2 — zaplanuj **konkretną reakcję**. Co zrobisz, gdy impuls się pojawi? Reakcja konkurencyjna, decoupling, surfowanie, kontakt z bliską osobą — wybierz to, co u Ciebie działa.

PLAN DLA SYTUACJI #1

PLAN DLA SYTUACJI #2

PLAN DLA SYTUACJI #3

— co konkretnie zrobisz

04 Co zrobić po potknięciu — 4 kroki

1 · SAMOWSPÓŁCZUCIE

„To jest trudne. Jeden epizod nie kasuje miesięcy pracy”. Bez samokrytyki. Co powiedziałbym/-abym przyjacielowi?

2 · ANALIZA, NIE OSĄD

Co poprzedzało? Jaka sytuacja, emocja, myśl? *Lapse jako dane* — informacja o luce w planie.

3 · PIELĘGNACJA SKÓRY

Zajmij się uszkodzeniami — dezynfekcja, emolient, plaster hydrokoloidowy. To *fizyczna troska*, nie kara.

4 · POWRÓT DO PLANU

Następna sytuacja → reakcja konkurencyjna. *Nie* „od poniedziałku zaczynam od nowa” — wracasz natychmiast, nie czekasz.

Klucz: realistyczne oczekiwania = długoterminowy sukces. **Celem nie jest „zero dłubania na zawsze”** — to jest niewykonalne i generuje *abstinence violation effect*. Realistyczny cel: *redukcja częstotliwości, intensywności i konsekwencji*. Selles i in. (2016, meta-analiza): u większości pacjentów po HRT dłubanie nie znika całkowicie, ale staje się znacznie rzadsze (z 5-10 epizodów/dzień do 1-2/tydzień), krótsze (z 30 min do 2-3 min) i mniej szkodliwe (bez krwi, bez blizn). To *jest sukces*. **Praktyczna wskazówka:** aktualizuj plan profilaktyki co 3 miesiące. Twoje sytuacje wysokiego ryzyka *zmieniają się* w czasie — nowa praca, nowe relacje, zmiany hormonalne. Plan z roku temu może już nie pasować. Bowen w MBRP: każdy lapse to *okazja do nauki*, nie powód do wstydu. Mózg uczy się powoli — daj mu czas i bądź dla siebie cierpliwy/-a.